

CAPÍTULO 8.23

Cirugía Pediátrica

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cirugía Pediátrica II: Malformaciones Congénitas

Comparación General

TABLA 8.23.1: PATOLOGÍA VS ¿QUIÉN?

PATOLOGÍA	¿QUIÉN?	SÍNTOMA PRINCIPAL	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO
Hernia diafragmática congénita	RN (desde nacimiento)	Dificultad respiratoria grave	Rx tórax	VM alta frecuencia → cirugía electiva
Atresia esofágica	RN (desde nacimiento)	Sialorrea + dificultad respiratoria	SNG + Rx	Cirugía
Atresia duodenal	RN (día 1)	Vómitos postprandiales desde nacimiento	Rx (doble burbuja)	Cirugía
Estenosis hipertrófica del píloro	RN (semana 2–6)	Vómitos explosivos	Eco	Piloro-tomía de Ramstedt
Enfermedad de Hirschprung	RN (primeros días/semanas)	Retraso eliminación meconio + obstrucción	Rx + biopsia	Cirugía (resección)
Ano imperforado	RN (desde nacimiento)	No elimina meconio + no tiene ano	Clínica (inspección)	Cirugía

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Sialorrea en RN = atresia esofágica hasta demostrar lo contrario. Siempre intentar pasar SNG al nacer.

• **Tratamiento:** cirugía (anastomosis esofágica + cierre de fístula traqueoesofágica)

3. Atresia Duodenal

- **Causa:** malformación congénita (obstrucción del duodeno)
- **Clínica:**
 - - **Vómitos desde el primer día de vida** (vomita inmediatamente post-ictal)
 - - Signos de deshidratación
 - - Meconio puede eliminarse solo 1 vez (luego no hay más, porque no hay alimento que pase)
 - - Meconio a veces de color blanco (bilis no alcanza el intestino)
- **Diagnóstico:** Rx de abdomen (imagen de **doble burbuja**: estómago + duodeno dilatado)

NOTA CLÍNICA

Diagnóstico diferencial: Enterocolitis necrotizante también da vómitos en RN + Rx anormal. Diferencia: ECN muestra neumatosis intestinal y dilatación difusa; atresia duodenal muestra doble burbuja.

• **Tratamiento:** cirugía

1. Hernia Diafragmática Congénita

- **Causa:** defecto del diafragma → vísceras abdominales van al tórax → hipoplasia pulmonar grave
- **Clínica:**
 - - Dificultad respiratoria grave (hipoplasia pulmonar)
 - - Ruidos hidroaéreos **en el tórax**
 - - Abdomen **excavado** (vacío — las vísceras están arriba)
- **Diagnóstico:** Rx de tórax (asas intestinales en el tórax)
- **Tratamiento:**
 - 1. **Intubación + ventilación mecánica de alta frecuencia** (pulmones pequeños → poca distensibilidad → no tolera volúmenes grandes)
 - 2. Cirugía **electiva** posteriormente (una vez estabilizado el paciente)

4. Estenosis Hipertrófica del Píloro

- **Causa:** idiopática (posible factor genético y uso de eritromicina en la madre)
- **Clínica:**
 - - Inicio entre la **semana 2 y semana 6** de vida (no desde el primer día)
 - - **Vómitos explosivos** postprandiales (proyectivos — no simples regurgitaciones)
 - - Avides por comer (lactante con hambre, no se sacia)
 - - Signos de deshidratación
 - - Oliva pilórica palpable (a veces)
- **Electrolitos:** hipocalcemia + alcalosis metabólica (por pérdida de ácido en vómitos)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diferencial por electrolitos: - Hipocalcemia + alcalosis → **Estenosis hipertrófica del píloro** - Hipercalcemia + acidosis → **Hiperplasia suprarrenal congénita** (misma edad, misma clínica — solo los electrolitos diferencian)

- **Diagnóstico:** Ecografía abdominal (píloro engrosado: músculo > 4 mm de espesor)
- **Tratamiento:** **Piloro-tomía de Ramstedt** (sección longitudinal del músculo pilórico)

5. Enfermedad de Hirschprung

- **Causa:** ausencia de células ganglionares en el **plexo mientérico** (aganglioneosis) → zona del colon que no se relaja → obstrucción funcional
- **Clínica:**
 - - **Retraso en la eliminación del meconio** (normal < 24–48 h; si tarda más → sospecha)

EUNACOM CRITERIOS

EUNACOM preguntó: si dan la Rx y preguntan la conducta y aparece "cirugía" como alternativa → la respuesta más correcta es **intubación** (es lo más urgente e inmediato). La cirugía viene después.

2. Atresia Esofágica

- **Causa:** malformación congénita; en el **80%** asociada a **fístula traqueoesofágica**
- **Clínica:**
 - - **Sialorrea** desde el nacimiento (no puede tragar → se acumula saliva)
 - - **Dificultad respiratoria** (aspiración de saliva + malformaciones traqueales)
- **Diagnóstico:**
 - - Se intenta pasar SNG → no llega al estómago

- - Obstrucción intestinal incompleta progresiva: constipación severa, distensión abdominal
- - Ruidos hidroaéreos aumentados
- **Diagnóstico:**
- 1. **Enema baritado** (zona estrecha + dilatación proximal — imagen de "trompeta")
- 2. **Manometría anorrectal** (hipertonía en la zona agangliónica)
- 3. **Biopsia por succión** (confirma: ausencia de neuronas en el plexo) → **examen confirmatorio**
- **Tratamiento:** resección del segmento agangliónico + anastomosis término-terminal

6. Ano Imperforado

- **Causa:** malformación congénita; fuertemente asociado a **Síndrome de Down**
- **Clínica:**
- - No elimina meconio
- - Obstrucción intestinal muy precoz
- - **Al examen físico:** membrana tapando el ano (orificio anal ausente)
- **Diagnóstico: clínico** (inspección anal neonatal)

EUNACOM CRITERIOS

Todo recién nacido debe tener examen del ano. En RN con Síndrome de Down → siempre revisar el ano antes de afirmar que el bebé está bien.

- **Tratamiento:** cirugía (anoplastia + reconstrucción)

Resumen: Claves Diagnósticas

TABLA 8.23.2: PATOLOGÍA VS CLAVE DIAGNÓSTICA ÚNICA	
PATOLOGÍA	CLAVE DIAGNÓSTICA ÚNICA
Hernia diafragmática congénita	Asas intestinales en Rx de tórax
Atresia esofágica	Sialorrea + SNG que no pasa
Atresia duodenal	Doble burbuja en Rx de abdomen
EHP	Vómitos explosivos semana 2–6 + eco
Hirschprung	Meconio tardío + biopsia (sin neuronas)

| Ano imperforado | No hay ano en la inspección |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 5 semanas de vida, primogénito varón, consulta por vómitos explosivos de contenido lácteo no bilioso inmediatamente después de cada mamada desde hace 5 días. Tras vomitar muestra hambre voraz. Examen: deshidratado, se palpa pequeña masa móvil firme de 2 cm en epigastrio (oliva pilórica). Laboratorio: Gases venosos muestran Alcalosis Metabólica Hipoclorémica e Hipokalémica."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Estenosis Hipertrófica del Píloro: hipertrofia de la capa muscular circular del píloro. Típica en varones de 3 a 6 semanas con vómitos explosivos no biliosos y alcalosis metabólica hipoclorémica hipokalémica por pérdida de ácido clorhídrico gástrico. Diagnóstico de elección: Ecografía abdominal (grosor muscular pilórico > 3 mm y longitud > 15 mm). Manejo: Corrección hidroelectrolítica rigurosa previa a la cirugía + Píloromiotomía extramucosa de Ramstedt.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Enterocolitis necrotizante: triada de vómitos, distensión abdominal y hematoquecia en RN prematuro; neumatosis intestinal es el hallazgo radiográfico más característico
- Invaginación intestinal: lactante 6-12 meses con dolor, hiperflexión de caderas y deposiciones en mermelada; diagnóstico con eco (signo de la dona); tratamiento con descompresión neumática
- Divertículo de Meckel: hemorragia digestiva baja grave por mucosa gástrica ectópica; diagnóstico con cintigrafía con tecnecio
- Pólipos juveniles: rectorragia leve recurrente en escolares; diagnóstico y tratamiento con colonoscopia
- Hematemesis del RN: test de Apt-Downey diferencia sangre materna (amarillo) de sangre fetal (rojo)
- Régimen cero + nutrición parenteral total son la base del tratamiento de la enterocolitis necrotizante

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CIRUGÍA PEDIÁTRICA)

PREGUNTA 1

Recién nacido prematuro de 30 semanas, a los 5 días de vida presenta distensión abdominal, retención gástrica y deposiciones con sangre. En la radiografía de abdomen se observa aire en la pared intestinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Atresia duodenal
- B) Invaginación intestinal
- C) Enterocolitis necrotizante
- D) Enfermedad de Hirschsprung
- E) Vólvulo intestinal

PREGUNTA 2

Lactante de 8 meses presenta crisis de llanto súbito con hiperflexión de caderas y deposiciones en mermelada de frutilla. La ecografía abdominal muestra imagen en dona. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A) Laparotomía exploradora
- B) Descompresión neumática
- C) Enema baritado diagnóstico
- D) Observación y control en 24 horas
- E) Antibióticos endovenosos

PREGUNTA 3

Niño de 4 años presenta un episodio de hemorragia digestiva baja abundante. Al examen se encuentra pálido, taquicárdico, abdomen blando sin masas. ¿Cuál es el examen diagnóstico más apropiado?

- A) Colonoscopia
- B) Ecografía abdominal
- C) Cintigrafía con tecnecio
- D) Radiografía de abdomen
- E) TAC de abdomen con contraste

RESUMEN: CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Clase sobre cirugía pediátrica que aborda la enterocolitis necrotizante, la invaginación intestinal, el divertículo de Meckel, los pólipos juveniles y la hematemesis del recién nacido. La enterocolitis necrotizante afecta recién nacidos (prematuros, asfixia, sepsis) con tríada de vómitos, distensión abdominal y hematoquecia. Se diagnostica con radiografía de abdomen (neumatosis intestinal es lo más característico). Tratamiento: régimen cero, nutrición parenteral total, antibióticos, y cirugía si hay perforación. La invaginación intestinal afecta lactantes de 6-12 meses con dolor abdominal intenso, hiperflexión de caderas y deposiciones en mermelada de frutilla. Se diagnostica con ecografía (signo de la dona). Tratamiento: descompresión neumática de elección. El divertículo de Meckel (persistencia incompleta del conducto onfalomesentérico) se presenta con hemorragia digestiva baja grave o como diverticulitis similar a apendicitis. Diagnóstico con cintigrafía con tecnecio. Los pólipos juveniles producen rectorragia leve y recurrente en escolares. La hematemesis del recién nacido se evalúa con test de Apt-Downey para diferenciar sangre materna de fetal.